

УДК:616.681-006

Г.А.Серикбаев, Д.А.Тулеуова, А.К.Косаев, Ж.О.Мауленов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Непосредственные результаты хирургического лечения сарком мягких тканей

Аннотация. Саркомы мягких тканей являются относительно редким заболеванием и составляет 2% от всех онкозаболеваний. Наиболее часто встречаются фибросаркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы, липосаркомы, лейомиосаркомы, синовиальные саркомы.

Ключевые слова: фибросаркомы, злокачественные фиброзные гистиоцитомы, липосаркомы, лейомиосаркомы, синовиальные саркомы.

Цель работы - выработка оптимального объема хирургического вмешательства при злокачественных опухолях мягких тканей.

Обследовано 132 первичных больных со злокачественной опухолью мягких тканей. Всем больным первым этапом проведено хирургическое лечение.

Результат. Объем хирургического вмешательства зависит от стадии заболевания, морфологического строения опухоли, распространенности опухолевого процесса.

Ключевые слова: Саркома мягких тканей, хирургическое вмешательство.

Актуальность

Саркомы мягких тканей являются относительно редким заболеванием. От всех онкологических заболеваний составляет 2%, и 1% в структуре смертности. Наиболее часто встречаются фибросаркомы, злокачественные

Таблица 1 - Гистотип и стадия злокачественных опухолей мягких тканей

№	Нозология	Количество / %	Стадия / %	
			III	IV
1	Фибросаркома	26 / 19,7	24 / 92,3	2 / 7,7
2	Дерматофибросаркома	20 / 15,1	20 / 100,0	
3	Синовиальная саркома	26 / 19,7	25 / 96,1	1 / 4,9
4	Злокачественная фиброзная гистиоцитома	25 / 18,9	22 / 88,0	3 / 12,0
5	Липосаркома	19 / 14,4	19 / 100,0	
6	Рабдомиосаркома	16 / 12,1	15 / 93,7	1 / 6,3
	Всего	132	125 / 94,7	7 / 5,3

фиброзные гистиоцитомы, липо- саркомы, лейомиосаркомы, синовиальные саркомы.

Факторами, ассоциированными с неблагоприятным прогнозом больных саркомами мягких тканей, являются пожилой возраст (старше 60 лет), распространенность опухоли (более 5 см), степень ее злокачественности.

Саркомы мягких тканей - злокачественные, агрессивно текущие опухоли, склонные к развитию отдаленных метастазов и локальных рецидивов. Возникновение рецидивов зависит от объема хирургического вмешательства. После иссечения опухоли рецидивы возникают у 80-90% больных, а после широкого иссечения - только у 10-20%. Поэтому, нерадикальное удаление опухоли является одним из факторов неблагоприятного

Таблица 2 - Осложнения, полученные после проведения различных видов хирургического вмешательства

№	Вид операции	Кол-во / (%)	Осложнения		
			Нагноение (%)	Частичный некроз лоскута (%)	Дыхательно-сердечная недостаточность. (%)
1	Удаление опухоли с резекцией мышц, ребер, перикарда, диафрагмы с пластикой дефекта грудной стенки	12 (ОД)	1 (8,3)	1 (8,3)	2 (16,6)
2	Широкое удаление опухоли (фулярное удаление), с пластикой дефекта и без	95 (71,9)	4 (4,2)	4 (4,2)	
3	Широкое удаление опухоли с резекцией участка артерии, вены с пластикой сосудистым эндопротезом	2 (1,5)			
4	Межподвздошно-брюшная ампутация	4 (3,0)			1
5	Межлопаточно-грудная ампутация	6 (4,5)			1
6	Экзартикуляция суставов (тазобедренный, плечевой)	5 (3,8)			
7	Ампутация(н/ в/конечности)	8 (6,1)			
8	ВСЕГО	132	5 (3,7)	5 (3,7)	4 (3,0)

прогноза заболевания и требует скорейшего широкого иссечения опухоли.

Цель работы

- выработка оптимального объема хирургического вмешательства при злокачественных опухолях мягких тканей.

Материал и методы исследования. За период с 2006 по 2010 годы через отделение опухолей костей и мягких тканей прошло 132 первичных больных со злокачественной опухолью мягких тканей. Из них 26 пациентов с фибросаркомой, 20 пациентов с дерматофибросаркомой, с синовиальной саркомой было 26 больных, 25 больных - со злокачественной фиброзной гистиоцитомой, 20 пациентов - с липосаркомой и 16 - с рабдомиосаркомой. Гистотип опухоли был различен (таблица 1).

Результаты

Всем больным первым этапом проведено хирургическое лечение. Объем хирургического вмешательства отражен в таблице 2.

Широкое удаление опухоли с резекцией участка артерии, вены с пластикой сосудистым эндопротезом проведено наибольшему количеству больных (95) и ни у одного больного не наблюдалось осложнений. Низкий процент осложнений достигнут путем тщательной предоперационной подготовки, коррекцией сопутствующей патологии, выбора оптимального объема хирургического вмешательства.

Вывод

Объем хирургического вмешательства зависел от стадии заболевания, морфологического строения опухоли, распространенности опухолевого процесса.

Тұжырым

Г.А.Серикбаев, Д.А.Тұлеуова, А.К.Косаев, Ж.О.Мауленов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Жұмсақ тін саркомасының хирургиялық емінің тікелей қорытындысы

Бұл зерттеудің мақсаты орталық бронх және кеңірдектегі зақымдалған ісікке эндотрахеобронхиальды операция жасау кезінде анестезиологиялық камтамасыз етудің тиімділігі.

Науқастардың компенсацияланған тынысалу жетіспеуі ілігінде әсерлері бірдей болғандықтан, екі әдісті қолданды мүмкін - ингаляция және тамырақылы.

Гипоксемияның өсуін болдырмау үшін компенсацияланған тынысалу жетіспеушілігі бар науқастарға лайықты ем қолдану, басқарушы гипотония орташа артериялық қысымның 60-70 мм рт. ст. инфузия пропופол 4-12 мг/кг-ч үздіксіз жіберу және изокет 2-4 мг/ч фентанилмен қосылып 1,9 мг/кг-ч

Түйінді сөздер: Жұмсақ тін саркомасы, хирургиялық араласулар

Summary

G.A.Serikbaev, D.A.Tuleuova, A.K.Kosayev, Zh.O.

Maulenov

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Short-term results of surgical treatment of soft tissue sarcomas

Soft tissue sarcomas are relatively rare disease, and 2% of all cancers. The most common are fibrosarcoma, malignant fibrous histiocytoma, liposarcoma, leiomyosarcoma, synovial sarcoma.

Purpose - to develop the optimum volume of surgery for malignant soft tissue tumors.

Material and methods. The study involved 132 patients with primary malignant tumor of the soft tissues. All patients first stage underwent surgical treatment.

Results. The surgical procedure depended on the stage of the disease, the morphological structure of the tumor, the prevalence of cancer.

Keywords: sarcoma of soft tissue surgery.